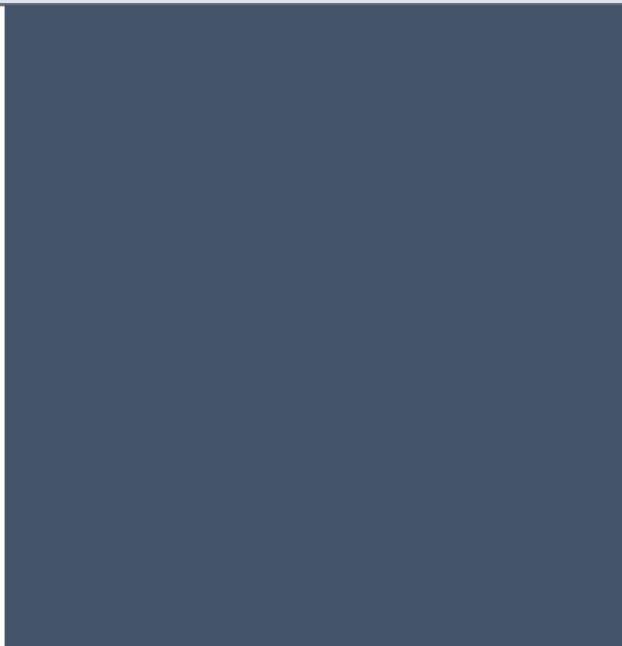




תסמונת שחיקה אצל רופאים ודת
כדרך התמודדות

מגיש: אשר טרגין

תז: 311631543

asher taragin



תופעת השחיקה אצל רופאים הינה לצערנו תופעה מאוד רווחת כיום המשפיעה לרעה על רווחת הרופאים ובעקיפין על רווחת המטופלים. במחקרים השונים בנושא הוצעו מספר דרכי התמודדות, במאמר זה אבחן שיטה מרכזית אחת שהועלתה בעבר בספרות הרפואית כיעילה להפחתת שחיקה- הדת.

נושא זה הינו מאוד משמעותי עבורי בתור סטודנט לרפואה העתיד לחוות חוויה מעין זו. במהלך לימודי הרפואה וכן לאחר מכן מתואר בספרות כי קיימת תופעת של שחיקה אשר יכולה להוביל לדיכאון. כדי להימנע ולנסות להתמודד בבעיה זו בחנתי מספר פתרונות. בתור אדם דתי, תהייתי האם אכן אוכל להשתמש ברקע הדתי ולהיעזר בו אל מול סכנת השחיקה, הרובצת על פתח מקצוע הרפואה.

שאלת מחקר- האם הדת יכולה להוות כלי בהתמודדות מול השחיקה?

הגדרת השחיקה

תופעת השחיקה המקצועית קבלה התייחסות רבה בעשורים האחרונים במחקרים התיאורטיים והקליניים. פראודנברגר¹ היה הראשון שהגדיר את המונח שחיקה. לפיו, העובד השחוק הוא אדם נוקשה, עקשן ובלתי גמיש. הוא מתאר מצב של עייפות והתרוקנות הכוחות הפיזיים והנפשיים הנובעים משאיפות מוגזמת של האדם להשיג תוצאות לא ריאליות. פראודנברגר מוסיף כי אנשים העובדים במקצועות סיוע (כגון רפואה) ימצאו עצמם תחת לחץ הולך וגובר להצליח בתפקידם, אנשים אלו יתבעו מעצם מסירות ומאמץ נוספים עד שלבסוף יכרעו תחת הנטל.

במשך השנים התווספו הגדרות וגישות נוספות, כאשר את ההגדרה הכוללת ביותר לתופעת השחיקה הציע פרבר². לפיו, השחיקה נובעת מכך שהיחיד תופס כי קיים פער ממשי בין המאמץ שהוא עושה לבין התגמולים שהוא מקבל בעבודתו. היא מופיעה לעתים קרובות בקרב אלה העובדים עם לקוחות הזקוקים לעזרה. מאפייניה הם התרחקות מן הלקוחות ותגובה צינית כלפיהם הנלוות בתשישות נפשית וגופנית.

¹ Freudenberger, H. J. (1974). *Staff burnout*. Journal of Social Issues, 30 (1), 159-164.

² Farber, B. A. (1991). *Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

תיאור נוסף של השחיקה ניתן לפי צ'רניס³. לדבריו, השחיקה היא שינוי של עמדות העובד בכיוון שלילי כתוצאה מלחצים בעבודה. הוא מתייחס בעיקר לירידה במוטיבציה ולאובדן תחושת השליחות בעבודה. צ'רניס חידש כי השחיקה נובעת גם מאופי וטיב התקשורת בארגון. כלומר, ארגון המגביל את העובד, מצמצם את עצמאותו ולא מספק לו גירויים אינטלקטואליים, גורם לשחיקת עובדיו. מנגד, תפקיד מעניין ומאתגר והאינטראקציה החיובית בין אנשי הצוות יוצרים תחושות של יעילות והצלחה המשפיעים ומקטינים את ממדי השחיקה בעבודה.

על בסיס דעות אלו גיבשו מסאלח וג'קסון⁴, שלושה רכיבים לתסמונת השחיקה. **הראשון**- התשישות, דהיינו עייפות, תחושת חוסר אנרגיה ועבודה קשה. **השני**- היעדר הגשמה אישית, כאשר העובד מרגיש כישלון בעבודה והיעדר הישגים. **השלישי**- דה-פרסונליזציה, המתבטא בהתייחסות אל הזולת כאל חפץ, המתבטאת בגישה צינית, לא אכפתית ולא אנושית.

ממדי שחיקת הרופאים

לאור כל הסיבות לשחיקה שהוצגו לעיל, ניתן לומר כי קבוצת הרופאים היא קבוצת סיכון לשחיקה מעבודתם. הם אכן נתונים תחת לחץ גובר (במיוחד במדינת ישראל), עובדים עם לקוחות הזקוקים לעזרה והם לא תמיד מקבלים את עצמאותם ושכר מתגמל במסגרת עבודתם.

אכן, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגדלה של שחיקה אצל רופאים. כאשר כיום, רמת התסמונת הזו הגיעה לממדים אדירים אצל כלל הרופאים⁵, כאשר ההערכה היא כי שליש מרופאי החירום מציגים סימנים פסיכולוגיים קשים של מצוקה ושחיקה וכשבעים אחוז של רופאים במדינות שונות (ארה"ב, טורקיה, אירופה) מראים סימנים קלים של עייפות רגשית וניתוק. התסמונת הזו רלוונטית לרופאים בכל שלבי הכשרתם ללא תלות במגדר, החל מבית הספר לרפואה ועד להיותם בכירים. כאשר נמצא כי אצל המתמחים בשנה הראשונה להתמחות נרשם שיא בממדי השחיקה⁶ וכי ישנה יותר שחיקה בשנים הקליניות מאשר בשנים הפרי קליניות⁷.

³ Cherniss, C. (1980), *Professional Burnout in Human Service Organizations*. New-York: Prager.

⁴ Maslach, C., & Jackson, S. (1981). *The measurement of experienced burnout*. *Journal of Occupational Behavior*. 2, 1-15.

⁵ האחוזים המדויקים תלויים בתחום הרופא, כך למשל אצל גניקולוגים נרשם רמה גבוהה של שחיקה ואילו אצל רופאי משפחה נרשם רמה נמוכה של שחיקה.

⁶ Braun SE, Auerbach SM, Rybarczyk B, Lee B, Call S. *Mindfulness, burnout, and effects on performance evaluations in internal medicine residents*. *Adv Med Educ Pract*. 2017;8:591-597.

⁷ Wachholtz A, Rogoff M. *The relationship between spirituality and burnout among medical students*. *Journal of contemporary medical education*. 2013;1(2):83-91. doi:10.5455/jcme.20130104060612. להלן: Wachholtz A, 2013

ההסתדרות הרפואית הקנדית הצביעו על ששה גורמים שונים שיכולים להשפיע ולהעלות את מידת סיכון התפתחות שחיקה אצל רופאים: עומס עבודה, חסך בשינה, ריבוי תפקידים מקבילים (הוראה, מחקר וטיפול), חשש מפני תביעות משפטיות, עלייה בדרישה של החברה לטיפול רפואי ותובענות של מטופלים.⁸

סכנת השחיקה

בעיית השחיקה אותה הצגנו עד כה, איננה דבר של מה בכך, שכן יש בה תוצאות הרות אסון. כך למשל, נמצא כי קיים קשר בין שחיקה אצל רופאים לתחושת חרדה, סיכון מוגבר למחלות לבביות ופעילות פחותה של בלוטת האדרנל ואף שיעור גדל של התאבדויות.⁹

תופעת השחיקה הינה משמעותית עברינו כיום אף בתור מטופלים, מכיוון שקיים קשר בין שחיקה לבין איכות הטיפול של רופאים- רופאים נותנים טיפול פחות מקצועי כאשר הם מרגישים שחוקים. כך למשל במחקר הכולל שלושת אלפים סטודנטים לרפואה בשבעה בתי ספר לרפואה בארה"ב נמצא כי השחיקה הייתה פקטור מאוד משמעותי להתנהגות רשלנית ופחות אלטרואיסטית.¹⁰ לפיכך, היום, כאשר קיים חוסר הולך וגדל של רופאים הרי שעלינו לדאוג לשמור על יכולת הטיפול והבריאות הפיזית והנפשית של הרופאים שברשותנו.

להתמודדות עם בעיה משמעותית זו, קיימים מספר אפשרויות בספרות הרפואית. כאשר כעת נתעסק בעיקר באחת- דת.

דת כפתרון לשחיקת רופאים

ישנו בסיס לטענה כי הדת משפיעה על אורח חייו של האדם שכן כבר הוכח כי קיים קשר מאוד משמעותי בין דת לבין תחומי התנהגות אחרים- הדת מפחיתה שימוש בעישון, אלקוהול וסמים. בשנים האחרונות אף מצאו כי הדת מונעת שחיקה אצל עובדי הוראה.¹¹

סקירה ספרותית

⁸ Puddester DG. Physician health and well-being: Canada's national approach. Med J Aust 2001;175:63-4.

⁹ Melamed S, Shirom A, Toker S, Berliner S, Shapira I. Burnout and risk of cardiovascular disease: evidence, possible causal paths, and promising research directions. Psychol Bull. 2006;132(3):327-353.

¹⁰ Wachholtz A, 2013

¹¹ Somech, A. & Miassy-Maljak, N. Social Psychology of Education (2003) 6: 61.

במרבית המחקרים היה ניכר כי קיים קשר בין דת ושחיקה אצל רופאים¹² ואצל מטפלים רפואיים אחרים כגון אחיות ברפואת חירום¹³. כלומר מטפלים שחיו לפי אמונותיהם הדתיות הפחיתו את רמת השחיקה. מסקנה זו כוללת אנשים דתיים משלל הדתות ואף כאלו שהרגישו רוחניים ולא בהכרח דתיים. אמנם, באחד המחקרים טענו כי לא מצאו קשר הדוק בין דת לשחיקה אך הראו שחלק מהמרכיבים המצויים בדת הפחיתו את תופעות הלוואי של השחיקה. למשל שאצל הדתיים השומרים יום מנוחה במסגרת הדת קיימים אחוזי תביעות רפואיות נמוכים¹⁴.

כלי היהדות מול השחיקה

ערך הרפואה ביהדות

מאז ומתמיד מצינו כי את שילוב הדת והרפואה. כך למשל, מרבית הכמרים במאות שנים האחרונות שימשו גם כרופאים. כמו כן, הכוהנים בתורה שימשו בתור מאבחני מחלת הצרעת. אף כלפי האל ניתן התואר בתורה 'רופא'¹⁵:

וַיֹּאמֶר אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל יְקֹוֹק אֱלֹהֶיךָ וְהִיָּשֵׁר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶׂה וְהֶאֱזַנְתָּ לְמִצְוֹתָיו וְשִׁמַּרְתָּ כָּל חֻקָּיו כָּל הַמִּחְלָה אֲשֶׁר שִׁמַּתִּי בְּמִצְרַיִם לֹא אֲשִׁים עֲלֶיךָ כִּי אֲנִי יְקֹוֹק רַפָּאִי.

כמו כן, התורה מתירה ורואה את הרפואה באור חיובי. כך נראה מהפסוק בתורה¹⁶ ממנו למדים כי האדם יכול וצריך ללכת לרופא במצב של חולי:

אִם יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ בַּחוּץ עַל מִשְׁעָנָתוֹ וְנָקָה הַמֶּכָּה רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפָּא יִרְפָּא:

התורה שם עוסקת במצב בו שני אנשים נקלעו למריבה ואחד מהם נפגע, על המכה לשלם על הנזק הכולל את כסף הריפוי שהוצא הניזוק. לפי זה מסיקים שעל הניזוק וכל אדם צריך ללכת לרופא כאשר הוא חולה, על האדם להתפלל לאלוהים אך בנוסף מוטלת עליו גם חובה ללכת לרופא, כדברי התלמוד¹⁷ בהסבר הפסוק הנ"ל:

ורפא ירפא - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.

¹² Wachholtz A, Rogoff M. The relationship between spirituality and burnout among medical students. Journal of contemporary medical education. 2013;1(2):83-91. doi:10.5455/jcme.20130104060612.

¹³ Kim HS, Yeom HA. The association between spiritual well-being and burnout in intensive care unit nurses: A descriptive study. Intensive Crit Care Nurs. 2018;.

¹⁴ Salmoirago-blotcher E, Fitchett G, Leung K, et al. An exploration of the role of religion/spirituality in the promotion of physicians' wellbeing in Emergency Medicine. Prev Med Rep. 2016;3:189-95

¹⁵ שמות פרק טו פסוק כו

¹⁶ ספר שמות פרק כא, פסוק יט.

¹⁷ תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד א

יתר על כן, על פי התורה ישנו ערך רב לעסוק במקצוע הרפואה מכמה סיבות. ראשית, הרמב"ן¹⁸, מפרשני התורה מסביר כי כל רופא המטפל בתורה מקיים את מצוות 'פיקוח נפש'- החובה של האדם לדאוג על חייו ועל חיי אחרים. יוצא אם כן כי בתורה מצוות הרפואה איננה רק על המטופל הזקוק לטיפול אלא בעיקר על המטפל:

מצווה היא לרפאות, בכלל פקוח נפש הוא... ופקוח נפש מצווה רבה היא.

מצווה דתית נוספת אותה מקיים הרופא בעבודתו הינה מצווה כללית החשובה ביותר ביהדות:

לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יְקוֹק¹⁹:

חובה מוסרית דתית ביהדות לנסות לדאוג לכל יהודי כפי שאדם היו רוצים שיתנהגו כלפיו. כאשר רופא מטפל בחולה הרי שהוא דואג לאחר כפי שהיה הוא, הרופא, רוצה שידאגו ויטייחסו אליו. יוצא אם כן, כי רופא אשר דתי אינו רק מרוויח כסף על עבודתו אלא גם מקיים מצווה בכל רגע אשר הוא עוסק בדאגה לזולת ומרפאו.

תחושת קיום רצון האל ועזרה לאחר מביאה את הרופא לתחושת סיפוק. כל זאת מתוך הבנה כי קיים מצווה מהאל לטפל בחולים, אשר מביאה את האדם לתחושת רוגע ולתחושת סיפוק. רעיון כזה בא לידי ביטוי אף בדת האסלאם- במסגרת מחקר העוסק באחיות מאירן²⁰. שם נאמר כי על פי הקוראן הרי שיש לראות בכל תחומי החיים ובמיוחד ברפואה מצווה מאלוקים. האחיות אף העידו כי העבודה בתור אחיות מהווה עבודה דתית יותר משמעותית מאשר הכסף ולכן הם אינם מרגישים עייפות.

בנוסף רבים מהם ראו בכך ניסיון מאלוקים, כאשר אם אדם עומד בפניהם כיאות הרי שמובטח לו תמורה בעולם הבא שכולו טוב. ממילא קיים תמריץ, ותחושת סיפור שיכולה להוציא את האדם מתחושת הדיכאון והתסכול הנחשבים ככישלון בניסיון.

סדר יומי ומחשבותי

דרך נוספת בה הדת יכולה למנוע שחיקה הינה הסדר המחשבתי שהיא מעניקה. הדת מעניקה מסגרת בהם הרופאים יכולים לראות בו מקצת הגיון וסדר²¹. הסדר הינו מאוד משמעותי לרופאים שכן הם נאלצים להתמודד עם סיטואציות מאוד דרמטיות ומלחיצות במקרי חירום. הסדר יכול

¹⁸ רמב"ן, ספר שמות פרק כא פסוק יט.

¹⁹ ויקרא פרק יט פסוק יח

²⁰ Salaree MM, Zareiyan A, Ebadi A, Salaree M. Coping strategies used by Iranian nurses to deal with burnout: a qualitative research. Glob J Health Sci. 2014;6(6):273-80

²¹ Salmoirago-blotcher E, Fitchett G, Leung K, et al. An exploration of the role of religion/spirituality in the promotion of physicians' wellbeing in Emergency Medicine. Prev Med Rep. 2016;3:189-95

להתקיים על ידי המצוות בדת, כגון החובה להתפלל שלוש תפילות ביום או לשמור שבת כל יום שביעי.

לחלופין, הסדר אף יכול להיות יותר משמעותי ועמוק בתחום תפיסת העולם, למשל האמונה הדתית כי כל דבר נעשה בידי האל לטובה. הן החיים והן המוות יכולה להשפיע רבות על תחושת הלחץ והדיכאון של הרופא.

לדוגמא, במקרים בהם ימות מטופל אצל הרופא יוכל הרופא הדתי להתנחם ולהירגע בכך שלפי האמונה הדתית יהודית:

"כי עת לכל חפץ תחת השמים עת ללדת ועת למות"²².

ריפוי מסגנון כזה עושה כל אבל דתי ביהדות כאשר מברך סמוך לקבורה על קרובו הנפטר "ברוך דיין האמת", בשל האמונה כי נעשה באמת בידי האלוקים, בתקווה שבצורה זו יוכל אדם להתמודד בצורה יותר טובה עם המציאות הקשה שלפניו²³.

היהדות וערך העבודה

היבט נוסף המשמעותי בשיפור ההתמודדות מול השחיקה הינו ערך הרב שהיהדות נותנת לעבודה. הרחיבה לתאר זאת סומך²⁴ בעבודתה אשר תוארה לפני כן:

"Judaism has also concerned itself with the value of work. Early Jewish thinkers considered the nature and meaning of work and the contribution of work to society and to lives of its members"

סומך מסבירה כי העבודה תורמת לאדם בשל הערך העצמי של העבודה כשלעצמו וגם בשל התרומה הרבה אשר היא מביאה לחברה. כל עבודה בצורה המיוחדת לה. כך למשל מורה יכול לתרום לחברה בחינוך תלמידיו ואדם העוסק בהיי-טק יוכל לתרום בפיתוח החברה בהיבט הטכנולוגי.

כהוכחה לשיטתה הביאה סומך את דברי התלמוד²⁵:

²² תנ"ך, ספר קהלת פרק ג, פסוקים א-ב

²³ שולחן ערוך, אורח חיים, הלכות ברכות, סימן רכ"ב סעיף ג'

²⁴ Somech, A. & Miassy-Maljak, N. Social Psychology of Education (2003) 6: 61.

²⁵ תלמוד בבלי קידושין כט עמוד א

רבי יהודה אומר: כל שאינו מלמד את בנו אומנות - מלמדו ליסטות. ליסטות סלקא דעתך (תרגום: האם אדם שלא מלמד את בנו באמת נחשב כאילו מלמדו פשע)?! אלא, כאילו מלמדו ליסטות.

כלומר מגמרא זו רואים עד כמה משמעותי הצורך ללמד את הבן יכולת עבודה עד כדי כך שמי שלא עושה זאת משפיעה לרעה ומשחית את נפש בנו עד כדי ליסטות. דומה שרעיון זה חוזר על עצמו מספר פעמים במקורות היהודים, כך מצינו במשניות במסכת אבות (ב,ב):

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון. **וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עון**

כלומר לדעת רבן גמליאל פה במשנה, אדם הלומד תורה צריך שתהיה לו גם עבודה בצידה. ללא עבודה הרי שהתורה והדת לא יכולים להתקיים ולעמוד. רבן גמליאל לוקח זאת צעד נוסף ואומר שמי שלא יעבוד הרי שהוא עתיד ליפול בעשיית עון.

כפי שסומך הגדירה זאת גם כן בעבודתה:

Work stabilizes the soul of man and protects him from crises²⁶.

לדבריה של סומך, העבודה שומרת על האדם משברון לב, משום שמסתכלים עליה בתור משימה, דך ליישם את הערכים אותם אדם קיבל ולמד בלימוד התורה הדתיים. עבודה זהיא משימה אשר מטרתה איננה רק רווח כלכלי אלא בעיקר רווח הדומה לזה של שמירת השבת או שמירת מצוות הכשרות, במילים אחרות דומה שניתן להגדיר זאת בתור- רווח בעבודת ה'.

ההסבר שהבאנו כעת, הינו מאוד כללי והינו רלוונטי לכאורה לכל עבודה ולא רק לעיסוק הרפואי, שכן בהרבה עבודות יש מימד של עשייה ואף תרומה לאחר, אך במסגרת עבודה זו לא נעסוק בתחומים אחרים.

²⁶ 2013 Somech

ראיון עם איש רפואה – ד"ר לנורד פיינר, רופא עיניים, עובד בב"ח וקליניקה פרטית (כבר 30 שנה) בלונג איילנד, ניו יורק

האם אתה הרגשת בעבר תחושת שחיקה?

אני הרגשתי כמה פעמים במשך הקריירה שלי תחושת שחיקה. הרגשתי את זה כאשר הייתי בלימודים ובהתמחות, גם היום ישנם פעמים שאני מרגיש תחושת שחיקה. אבל אני חושב שתחושת השחיקה שלי היא מאוד קלה כי אני מוצא דרכים להתמודד ולהתרענן. אני רואה כיצד אצל קולגות שלי יש יותר תחושת שחיקה וכיצד רבים מהם החליטו לפרוש לפנסיה בגלל תחושות מעין אלו. התחושה הכללית היא לקום בבוקר חסר מרץ ואני מרגיש שזה בהחלט יכול להשפיע על הלקוחות. הם יכולים להרגיש מתי אין לך כוח. אני מרגיש שמטופלים אוהבים להמשיך לבוא לקליניקה וזה נובע מכך שאני שמח ונהנה מכל יום בקליניקה.

לכמה זמן הרגשת שחוק?

השחיקה אצלי כפי שאמרתי הייתה די קלה, יכול להימשך למשך כמה שעות ביום אבל בדרך כלל לא מדובר במשהו רציני.

האם הרגשת שזה משפיע על היחס ועל איכות הטיפול שלך?

אני חושב שכן, כשאני שמח זה מאוד משפיע לטובה על איכות הטיפול. אבל כאשר קיים משהו שמטריד אותי אותו שחיקה אז זה פוגע באיכות הטיפול וביחס הטיפול.

כיצד התמודדת עם השחיקה?

אני מתמודד עם השחיקה במספר דרכים, ראשית כל אני תמיד אוהב ללכת להשתלמויות להישאר תמיד מעודכן בכל הדברים החדשים שמתפתחים. כך למשל הכנסתי אני ממשיך להכניס ציוד טכנולוגי חדש לתוך הקליניקה, להשתמש בתרופות חדשות ולהכניס צוות חדש שיביא אתו תחושת רעננות.

בנוסף, אני דואג כל יום לשחות, אני מרגיש שזה עוזר לי להשתחרר וזה נותן זמן לעצמי לשכוח מכל הדאגות.

האם הרגשת כי הדת עוזרת לך להתגבר/להימנע משחיקה?

בהחלט, אני כל יום קם בבוקר, נוסע לבית הכנסת ולומד בבוקר דף יומי [לימוד קבוע של דף בתלמוד בבלי ובכל 7.5 שנים מסיימים ומתחילים מחדש], לאחר מכן אני מתפלל שחרית. לקראת הערב אחרי העבודה אני נוסע להתפלל מנחה נשאר לשיעור ולאחר מכן מתפלל ערבית.

אני מרגיש שזה מאוד עוזר לי במציאת מסגרת ומציאת תחום אחר שאוכל להתעסק בו, סוג של התרעננות. אצלי זה במיוחד כל שבת כאשר אני לא מגיע לקליניקה. אני זוכר כיצד זה לא היה פשוט בתחילה, מכיוון שיהודים בארה"ב היו מכריחים אותם לבוא ולעבוד בימי שבת, אפילו בלימודים זה לא היה פשוט מכיוון שהייתי צריך להשיג אישורים חריגים לא לבצע את המבחנים ולהעדר משיעורים בימי שבת. אבל אני מרגיש שזה מאוד תרם לי ולמשפחתי. אני מתסכל על חברי לכיתה מאוניברסיטת קולומביה ומ Einstein hospital, ואני יוכל לראות כיצד הדת מאוד עזרה לי גם לשמור על רוגע במהלך הלימודים ובמהלך הקריירה.

בנוסף, אני מרגיש כי כל יום כאשר אני במרפאה אני עוזר לאנשים ומקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" מה שנותן לי תחושת סיפוק ותחושת שליחות. אני חושב שזה מאוד חשוב למצוא תחביבים שיהיה אפשר להתעסק בהם והדת אצלי בהחלט נחשב עיסוק משמעותי.

ראיון עם סטודנט לרפואה (שנה ג') – נעם שלינגר

האם אתה מרגיש שבמהלך הלימודים אתה שחוק?

כן קצת, לא יודע אם זה בדיוק שחיקה אבל יש תחושה של מצוי של למידה תיאורטי שאינו קליני שרחוק מהדבר עצמו. אצלי זה מתבטא בפחות מוטיבציה פחות השקעה והגעה לשיעורים. אם בשנה א' פתחתי את השנה בהתרגשות, הגעתי והשקעתי בכל הקורסים היום אני מצטער על זה שכבר אין לי כוח, ורצון. זה קצת מעלה בי חששות לגבי העתיד היותר רחוק ולקוות ששחיקה כמו שיש לי עכשיו לא תהיה.

אם כן- מדוע?

כבר שנה שלישית של לימודי מבוא, אנו לומדים על כל מיני מחלות אבל לא רואים אותם בעין. זה אותה המסגרת כל יום שבסופה יש תקופת מבחנים מאוד מתישה. כאשר אני לא מרגיש שהגעתי עדיין למטרה שבשבילה התגייסתי. מאמין שיהיה יותר מוטיבציה כשיגיע לקליני.

האם אתה מצליח לנהל אורח חיים דתי במהלך הלימודים?

כן, אני הולך לשיעורים. לומד רמב"ם יומי. זה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי אף מעבר לקיום המצוות היומיומית כתפילה וברכות.

האם זה תורם לך בתחושה זו של שחיקה?

בשני כיוונים שונים זה עזר לי. זה נתן לי פרופורציה לחיים, להרגיש שייך למשהו גדול עולם יותר עשיר יותר מלא בדברים. בנוסף, זה מחזק לי את תחושת השליחות- משהו מוכוון, התחושה כי זה התפקיד שלי להיות פה. אני מרגיש שהתפיסה הזו נובעת מתוך תפיסה דתית -ה' רוצה אני לעשה טוב. לתהליך הלימודים עצמם הרגשתי שזה פחות נתן לי כח. אבל אני מבין שכדי להיות רופא נדרשת הכנה.

לפי האמונה שלי, בתור יהודי, אני רואה ערכיות בעבודה כשלעצמה. גדלתי בתנועת בני עקיבא אשר הדגישה את החשיבות שיש בשילוב בין השתיים- תורה ועבודה. לכן אני מרגיש ששני הדברים הללו מחזקים זה את זה. כלומר אדם שלומד תורה מגיע עם כוחות ושאיפות בעבודה שעוזרים לו לעמוד בפני קשיים בעזרת נתינת משמעות.

האם היית מתנהל אחרת?

לא, אני חושב שיש משהו חזק ללמוד וזה לעבוד מתוך השגרה, מתוך העבודה שחוזרת על עצמה מתוך ניסיון ללמוד דברים חדשים ולחזק את הצורך לבוא אליהם בחזרה עם מוטיבציה. האמת, שייתכן להכניס לתוך השגרה לימוד של דברים תורניים, מסגרת חברתית דתית גם יכולה להיות משמעותית ולתרום.

גם לשאר הסטודנטים עניינים דתיים יכולים לעזור בתור מסגרת וגם ברמת העומק זה יכול להשפיע.

ניתוח ראיונות

לפי הראיונות אותם ביצענו במהלך המחקר האיכותני הרי שנראה שיש קשר ישיר בין היותם דתיים לבין יכולת ההתמודדות שלהם כלפי השחיקה. שני המרואיינים אכן העידו כי קיימת אצלם שחיקה, מה שמעיד שהיות אדם דתי לא מונעת שחיקה בצורה מוחלטת, אחרי הכל התורה נתנה לבני אדם הנתונים לשחיקה בצורה טבעית ולא למלאכים.

המרואיינים העידו שהאמונות הדתיות שלהם משפיעות על ההתמודדות של השחיקה שלהם בנוסף לגורמים אחרים שאינם דתיים אשר מועילים גם כן.

אצל ד"ר פיינר זה היה יותר עניין הסיפוק והערכיות שיש בעבודת הרפואה אשר תרמה לו בהתמודדות מול השחיקה, כדבריו: אני מרגיש כי כל יום כאשר אני במרפאה אני עוזר לאנשים ומקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" מה שנותן לי תחושת סיפוק ותחושת שליחות.

למרות שד"ר פיינר לא התייחס לכך במפורש, נראה שבדבריו היה גם אלמנט של הסדר אשר הדת נותנת לו בעולמו הרפואי: אני כל יום קם בבוקר, נוסע לבית הכנסת ולומד בבוקר דף יומי [לימוד קבוע של דף בתלמוד בבלי ובכל 7.5 שנים מסיימים ומתחילים מחדש], לאחר מכן אני מתפלל שחרית. לקראת הערב אחרי העבודה אני נוסע להתפלל מנחה נשאר לשיעור ולאחר מכן מתפלל ערבית. הסדר הזה הוא בנה לעצמו סביב העיסוק הדתי יכול לשמש בתור מסגרת מול השחיקה.

גם אצל נועם, הסטודנט לרפואה, התבטא עניין השליחות: זה מחזק לי את תחושת השליחות-משהו מוכוון, התחושה כי זה התפקיד שלי להיות פה.

אך בשונה מד"ר פיינר נועם התייחס לעיסוק בעבודה בצורה כללית: לפי האמונה שלי, בתור יהודי, אני רואה ערכיות בעבודה כשלעצמה. גדלתי בתנועת בני עקיבא אשר הדגישה את החשיבות שיש בשילוב בין השתיים- תורה ועבודה. לכן אני מרגיש ששני הדברים הללו מחזקים זה את זה. כלומר אדם שלומד תורה מגיע עם כוחות ושאיפות בעבודה שעוזרים לו לעמוד בפני קשיים בעזרת נתינת משמעות.

הסתייגות

במאמר עד כה, המחקרים שהבאנו מתבססים בעיקר על שאלונים. בבדיקות כאלו קיימת בעיה מהותית, כי מבחינה מדעית ייתכן ומסקנה המבוססת על שאלונים לא תחשבנה מדעית. זאת משום שקיים חשש נטיות מידע באסיפת חומר בצורה כזו²⁷, כך למשל ייתכן וישנה הטיית בחירה של העונים על השאלונים או של החוקרים המנסחים את השאלות, המנסים לשכנע את עצמם כי אמונתם אכן משפיעה ומשמעותית על אף שבפועל אין הבדל משמעותי. בנוסף, היחס לרגשות השחיקה יכולים להשתנות מאדם לאדם ולכן ייתכן והתוצאות אינם מדויקות דיו. אם כן ייתכן ויש להציע מדדים אחרים כגון- השוואה בין מספר הפיטורים בגין שחיקה, השוואה בהצלחות הניתוחים, השוואה בין תביעות רשלנות.

²⁷ Tripepi G, Jager KJ, Dekker FW, Zoccali C. Selection bias and information bias in clinical research. Nephron Clin Pract. 2010;115(2):c94-9.

מדד דתיות

בעיה נוספת בעבודה ובהנחות של הרבה מהמחקרים עליהם התבססתי במאמר היא שניתן למדוד את רמת הדתיות של אנשים ולפי זה לבדוק את רמת השחיקה שלהם.

ראשית היננו כי בחינת הדתיות איננה פשוטה, שכן ייתכנו כאלה הדתיים יותר מחבריהם, במיוחד כאשר לא ברור כיצד אפשר להגדיר מי נחשב יותר דתי מהאחר, ועל פי מה להתבסס. כך למשל לא יהיה ברור באוכלוסייה בארצנו מי ייחשב יותר דתי- החרדי? החסידי? הדתי לאומי? החילוני הערכי.

שנית, מכיוון שקיימים מספר דתות אפשרויות, ייתכן שהשחיקה תהייה שונה אצל יהודים מאשר אצל מוסלמים או נוצרים.

במאמרים אותם הבאנו השתמשו במדד אשר נקרא The Daily Spiritual Experiences Scale (DSE). סקאלה זו בנויה מששה עשר מרכיבים אשר עוצבו על ידי Dr. Lynn Underwood. בשאלון זה מעריכים כיצד האדם קולט את הטרנסנדנטיים בחייו הפרטיים על ידי התמקדות בחוויות ותחושות רוחניים. תחושות כגון יראה, הודאה, רחמים, תחושת חיבור ומודעות כלפי העילאי אלוקי, אהבה ותחושת שלווה פנימית.

אולם אף מדד זה אינו מדויק ואינו ספציפי כלפי דת מסוימת.

סיכום

בעבודה זו בחנו כיצד נמצא כי דת יכולה לעזור ולתרום לרופאים להימנע מלהגיע לכלל שחיקה.

ראשית בחנו את ההגדרות השונות שנתנו לשחיקה ואת הסיבות השונות אשר יכולים להביא כל אדם לידי שחיקה, במיוחד רופאים אשר לגביהם קיימים כל מיני גורמים אשר עלולים להביא לשחיקה יתרה- לחץ, עבודה המשרתת אנשים אחרים ועוד.

הראנו כי השחיקה מהווה סכנה לרווחת וחיי הרופאים והמטופלים ומדוע אם כן כל כך חשוב לנסות ולטפל בה. אכן בספרות הרפואית נעשו מודעים לבעיה זו שרק הוכלת והגדלה. אך מכיוון שבספרות הראו כי הדת יכולה לשמש בתור פתרון ואמצעי התמודדות בחנו כיצד בדת ישנם מרכיבים שונים היכולים לעזור.

הראנו כי הדת נותנת משמעות דתית לעיסוק ברפואה ולכל עבודה וגם כיצד בדת אדם יכול ליצור לעצמו סדר מול כל הכאוס הקיים מולו.

לסיום הובאו שתי ראיונות של אנשים העוסקים ברפואה אשר תיארו את התחושות שלהם לגבי שחיקה ולגבי הדת כפתרון לבעיית השחיקה.

- Kim HS, Yeom HA. *The association between spiritual well-being and burnout in intensive care unit nurses: A descriptive study*. Intensive Crit Care Nurs. 2018;.
- Maslach, C. (1993). Burnout: A multidimensional perspective. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), *Series in applied psychology: Social issues and questions. Professional burnout: Recent developments in theory and research* (pp. 19-32). Philadelphia, PA, US: Taylor & Francis.
- Maslach, C., & Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*. 2, 1-15.
- Somech, A. & Miassy-Maljak, N. *Social Psychology of Education* (2003) 6: 61.
- Melamed S, Shirom A, Toker S, Berliner S, Shapira I. *Burnout and risk of cardiovascular disease: evidence, possible causal paths, and promising research directions*. Psychol Bull. 2006;132(3):327-353.
- Puddester DG. *Physician health and well-being: Canada's national approach*. Med J Aust 2001;175:63-4
- Salmoirago-blotcher E, Fitchett G, Leung K, et al. *An exploration of the role of religion/spirituality in the promotion of physicians' wellbeing in Emergency Medicine*. Prev Med Rep. 2016;3:189-95.
- Salaree MM, Zareiyan A, Ebadi A, Salaree M. *Coping strategies used by Iranian nurses to deal with burnout: a qualitative research*. Glob J Health Sci. 2014;6(6):273-80.
- Shapiro SL, Carlson LE, Astin JA, Freedman B. Mechanisms of mindfulness. *Journal of Clinical Psychology*. 2006; 62(3): 373-386. <https://doi.org/10.1002/jclp.20237> PMID: 16385481
- Sayeed SA, Prakash A. *The Islamic prayer (Salah/Namaaz) and yoga togetherness in mental health*. Indian Journal of Psychiatry. 2013;55(Suppl 2):S224-S230. doi:10.4103/0019-5545.105537.
- Wachholtz A, Rogoff M. *The relationship between spirituality and burnout among medical students*. Journal of contemporary medical education. 2013;1(2):83-91.

Wachholtz AB, Pargament KI. *Is spirituality a critical ingredient of meditation? Comparing the effects of spiritual meditation, secular meditation, and relaxation on spiritual, psychological, cardiac, and pain outcomes.* J Behav Med. 2005;28(4):369-84.